下肢骨折和脱位 ★★★（0~3 题）		
	髋关节脱位（2022、2026）	股骨颈骨折（2007、2008、2010、2011、2016、2017、2019、2021）
好发部位	后脱位	
好发年龄		中老年骨质疏松
分型移位		骨折线部位：头下型（最重）、经颈型、基底型（最轻） Pauwels 角：外展（<30°稳定）、内收（>50°不稳定） 移位程度（Garden）：Ⅰ不完全骨折、或嵌插骨折；Ⅱ完全骨折不移位；Ⅲ完全骨折部分移位；Ⅳ完全骨折完全移位 颈干角 / 内倾角：≤ 110°髋内翻、≥ 140°髋外翻“小医大四”
临床表现	弹性固定、Shenton 线不连续 后脱位：屈曲内收内旋、臀部摸到股骨头、下肢缩短 前脱位：屈曲外展外旋、腹股沟摸到股骨头、下肢不定 “脱衣前是外衣、脱衣后是内衣”	外旋畸形 45° ~60° 下肢缩短（大转子上移）“NBS”： 超过 Nelaton 线、 Bryant 三角底边缩短、 Shoemaker 征
合并损伤	后脱位：坐骨神经	股骨头坏死 脂肪栓塞
保守治疗	后脱位 Epstein Ⅰ：Allis 提拉法 + 皮牵引 / 丁字鞋 （必须在全麻或腰麻下复位）	老年全身情况差不耐受手术：防旋鞋或牵引 待全身情况允许后尽快手术
手术治疗	后脱位Ⅱ - Ⅴ（合并关节内骨折）：切开复位 + 内固定	老年合并症多预期寿命短：半髋关节 / 股骨头置换术 老年合并症少预期寿命长的 Garden Ⅲ / Ⅳ：全髋关节置换术